

पुरुषों में तनाव मूत्र असंयम (SUI) का अर्थ है खाँसने, उठने, वजन उठाने या किसी गतिविधि के दौरान मूत्र का रिसाव होना। पुरुषों में यह लगभग हमेशा प्रोस्टेट सर्जरी या रेडिएशन के बाद मूत्र नियंत्रण की मांसपेशी (sphincter) के कमज़ोर होने से होता है। पहले साल में अक्सर सुधार होता है, और अगर नहीं होता, तो बहुत प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं।

इस स्थिति के बारे में

प्रोस्टेट निकालने के बाद मुख्य **urinary sphincter** (वह वाल्व जो मूत्र को रोकता है) अधिकतर काम करता है, और वह कमज़ोर हो सकता है। परिणाम है दबाव के साथ रिसाव — कुछ बूँदों से लेकर अधिक मात्रा तक। यह **urgency** रिसाव (पेशाब की तीव्र इच्छा के साथ) से अलग है, जिसका इलाज अलग होता है; कुछ पुरुषों में दोनों हो सकते हैं।

कारण

- **Radical prostatectomy** (कैंसर के लिए प्रोस्टेट हटाना) — सबसे सामान्य कारण
- अन्य प्रोस्टेट प्रक्रियाएँ या **pelvic radiation**
- कभी-कभी तंत्रिका या मूत्राशय की स्थितियाँ

रिसाव आमतौर पर **शुरुआत में सबसे अधिक** होता है और हफ्तों से महीनों में ठीक होता जाता है।

शब्दों को समझें

Stress incontinence

दबाव — खाँसने, उठने, वजन उठाने के साथ मूत्र रिसाव।

Sphincter

वह मांसपेशी-वाल्व जो मूत्र को रोकता है।

Prostatectomy

प्रोस्टेट हटाने की सर्जरी; पुरुष SUI का मुख्य कारण।

Pelvic floor

वे मांसपेशियाँ जिन्हें आप मूत्र नियंत्रण के लिए व्यायाम से मज़बूत करते हैं।

Pad test

प्रतिदिन कितने pad लगते हैं, यह गिनकर रिसाव की मात्रा मापना।

Male sling

मूत्रमार्ग के नीचे लगाया गया सहारा; हल्के-मध्यम रिसाव के लिए।

ProACT balloons

मूत्रमार्ग के पास दो समायोज्य गुब्बारे; office में ट्यून होते हैं।

Artificial urinary sphincter

कृत्रिम मूत्र sphincter (AUS) — प्रत्यारोपित उपकरण; मध्यम-गंभीर रिसाव के लिए।

क्या यह ठीक होगा? अक्सर हाँ — प्रोस्टेट सर्जरी के बाद रिसाव आमतौर पर पहले 6–12 महीनों में सुधरता है, खासकर pelvic floor व्यायाम से। अगर एक साल बाद भी रिसाव बना रहे, तो sling, adjustable balloons, या AUS पर विचार करें — ये सभी बहुत प्रभावी हैं।

जाँच कैसे होती है

- रिसाव कब और कितना होता है इसकी बातचीत (अक्सर **प्रतिदिन pad की संख्या** से मापा जाता है)
- **urine test** और मूत्राशय कितना खाली होता है इसकी जाँच
- सर्जरी से पहले: मूत्रमार्ग में देखना (cystoscopy) और कभी-कभी मूत्राशय-कार्य परीक्षण

इलाज कैसे होता है (चरण दर चरण)

- 1 **Pelvic floor व्यायाम (Kegels)**, आदर्शतः सर्जरी के समय से शुरू करें; साथ में तरल पदार्थ और वजन का प्रबंधन।
- 2 पहले साल **सुधार का इंतज़ार** करें; ज़रूरत के अनुसार pad/सुरक्षा का उपयोग।
- 3 **Male sling** — लगातार हल्के-मध्यम रिसाव के लिए।
- 4 **ProACT adjustable balloons** — हल्के-मध्यम रिसाव के लिए एक और विकल्प; office में कई बार ठूँन होते हैं (रेडिएशन के बाद उपयुक्त नहीं)।
- 5 **कृत्रिम मूत्र sphincter (AUS)** — मध्यम-गंभीर रिसाव के लिए मानक उपचार; रेडिएशन के बाद भी उपयुक्त। प्रत्येक के लिए अलग handout उपलब्ध है।

इसके साथ जीना

- Pelvic floor व्यायाम नियमित रूप से करें — यही आधार है।
- ठीक होते समय आत्मविश्वास के लिए pad या सुरक्षात्मक garment का उपयोग करें।
- रात में रिसाव हो तो शाम को तरल पदार्थ और caffeine कम लें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- जलन, बुखार, या **पेशाब में खून** (संभावित संक्रमण)
- अचानक **पेशाब नहीं होना**
- रिसाव बेहतर होने के बजाय बढ़ रहा हो

याद रखने योग्य तीन बातें

1. पुरुषों में SUI लगभग हमेशा प्रोस्टेट सर्जरी या रेडिएशन के बाद sphincter के कमज़ोर होने से होता है — और पहले साल में अक्सर सुधर जाता है।
2. Pelvic floor व्यायाम आधार है; लंबे समय के रिसाव के लिए male sling या AUS बहुत प्रभावी हैं।
3. सर्जरी का निर्णय एक साल बाद करें। बुखार, पेशाब में खून, या पेशाब न होने पर तुरंत संपर्क करें।